RG Bekken og hofter av barn

Endring siden forrige versjon

Revidert.Presisert; ved "Lauenstein Bilateralt (froskestilling)" tar man høyre og venstre side hver for seg der barnet samarbei der godt, men at barnet legger begge bein utover samtidig. Lagt inn eksempelbilder.

Indikasjon	Hofteleddsdysplasi	*Bekken AP Dysplasi*
	Calve Legg Perthes	*Bekken AP, Lauenstein bilateral (froskestilling)* ***Tilleggsprojeksjon:*** *Abduksjonsbilde strake bein*
	Episfysiolyse, kontroll av skade	*Bekken AP, Lauenstein*
	Skade 1. gangsundersøkelse	*Bekken AP, Innskutt*

BEKKEN AP DYSPLASI		Illustrasjon settes inn her
INFORMASJON	Utredning og kontroll av hofteleddsdysplasi på røntgen gjelder stort sett barn mellom 6-24 mnd.	
POSISJONERING	Pasienten liggende rett på ryggen uten rotasjon eller vinkel på bekkenet. Beinene legges parallelt med hverandre med føttene litt fra hverandre. Da blir caputs dekning av acetabulum riktig i forhold til acetabulum. Liten bøy i hofte- og kneledd, omtrent 45°. Beinene holdes av radiografkollega for å sikre korrekt leie.	
SENTRERING	Midt på pasienten, avhengig av pasientstørrelse like distalt for spina iliaca anterior superior (ASIS).	
STRÅLERETNING	0°	
BILDEKRITERIER	Hele bekkenet fremstilles uten rotasjon eller i feil vinkel. Femur ligger strakt ned for bekkenet parallelt med hverandre. Inkluder Os Ileum til proksimale femur.	
KOMMENTAR		
BEKKEN AP		Illustrasjon settes inn her
INFORMASJON	Calve Legg Perthes gjelder ofte barn i aldersgruppen 3-5 år. Epifysiolyse gjelder ofte barn i aldersgruppen 6-11 år.	
POSISJONERING	Pasienten liggende rett på ryggen uten rotasjon i bekkenet, bena roteres innover 15-20°. **OBS:** Ved spørsmål om **luksasjon** eller **brudd i femur** er innadrotasjon av aktuelt bein kontraindisert.	
SENTRERING	Midt på pasienten, avhengig av pasientstørrelse like distalt for spina iliaca anterior superior (ASIS). Ved spørsmål om patologi i femur/hofteledd er det ikke nødvendig å inkludere proksimale deler av bekkenet og sentrering i høyden blir som ved Lauenstein.	
STRÅLERETNING	0°	

BILDEKRITERIER	Hele bekkenet fremstilles uten rotasjon, med trochanter major i profil uten forkorting av collum femoris. L5 inkluderes øverst. Ved spørsmål om patologi i femur/hofteledd er det ikke nødvendig å inkludere proksimale deler av bekken eller L5.	
KOMMENTAR		
LAUENSTEIN BILATERALT (froskestilling)		Illustrasjon settes inn her
INFORMASJON	Der barnet samarbeider godt tar man **høyre og venstre hofte hver for seg**. Det er allikevel anbefalt at barnet legger ut begge beinene samtidig, da man enklere får de til å ligge symmetrisk likt.	
POSISJONERING	Pasienten liggende rett på ryggen uten rotasjon i bekkenet, med begge bein flektert i hofte og kne. Begge bein legges med maksimal abduksjon og utadrotasjon, med knærne så godt ned mot madrassen som mulig.	
SENTRERING	Midt på pasienten, i høyde med Collum femoris, avhengig av pasientstørrelse noen centimeter distalt for spina iliaca anterior superior (ASIS)	
STRÅLERETNING	0°	
BILDEKRITERIER	Begge Collum femoris i profil og forkortet, overprojisert av trochanter major. Inkluder ca. 1/3 av femur, opp til ASIS bilateralt.	
KOMMENTAR		
LAUENSTEIN		Illustrasjon settes inn her
INFORMASJON	Ved kontroll av skade er det ikke sikkert pasienten klarer **Lauenstein**. Alternativt tas **Innksutt**.	
POSISJONERING	Pasienten liggende rett på ryggen uten rotasjon i bekkenet, med aktuelt bein flektert i hofte og kne. beinet legges med maksimal abduksjon og utadrotasjon, med kneet så godt ned mot madrassen som mulig.	
SENTRERING	I høyde med Collum femoris, avhengig av pasientstørrelse noen centimeter distalt for spina iliaca anterior superior (ASIS)	
STRÅLERETNING	0°	
BILDEKRITERIER	Collum femoris i profil og forkortet, overprojisert av trochanter major. Inkluder ca. 1/3 av femur, opp til ASIS lateralt og symfysen medialt.	
KOMMENTAR		
INNSKUTT		Illustrasjon settes inn her
INFORMASJON		

POSISJONERING	Pasienten liggende rett på ryggen uten rotasjon i bekkenet, aktuelt bein liggende utstrakt, ikke aktuelt bein løftes med 90° fleksjon i kne og hofte. Detektor plasseres vertikalt, lateralt på pasienten, parallelt med collum femoris, med distale femur vendt ca. 45° fra detektor. **OBS:** Ved spørsmål om **luksasjon** eller **brudd i femur** er innadrotasjon av aktuelt bein kontraindisert.	
SENTRERING	Midt på collum femoris, omtrent lysken, samt noe posteriort for midtfemur-området, avhengig av pasientstørrelse.	
STRÅLERETNING	0°. Mediolateral stråleretning under ikke aktuelt bein.	
BILDEKRITERIER	Acetabulum, caput femoris og collum femoris fremstilles godt. Trochanter major overprojiserer kun distale del av en forlenget collum femoris, med kun en liten del av trochanter minor synlig. Tuberositas Ischii, samt 1/3 av femur inkluderes.	
KOMMENTAR		
ABDUKSJONS-BILDE		Illustrasjon settes inn her
INFORMASJON	I blant ønskes sprikebilde (abduksjonsbilde) ved Calve Legg Perthes for å bedømme hvordan den deforme caput dekkes av acetabulum i denne stillingen.	
POSISJONERING	Bildet tas fortrinnsvis stående, men kan også tas liggende. Bekkenet rett mot detektor uten rotasjon med strake ben med ren abduksjon uten utad- eller innadrotasjon. Beinene med så mye sprik som det er bedt om i henvisningen.	
SENTRERING	Midt på pasienten i høyde med Collum femoris, avhengig av pasientstørrelse noen centimeter distalt for spina iliaca anterior superior (ASIS)	
STRÅLERETNING	0°	
BILDEKRITERIER	Bekkenet fremstilles uten rotasjon, samt uten rotasjon av femur. Beinene spriker fra hverandre med så mange grader som det er angitt henvisning.	
KOMMENTAR		

Referanser

Vedlegg

V01 Retningslinjer ved henvisning og booking; RG Columna og/eller bekken og hofter på barn under 18 år (A.1.1/2.2.1-03)

Slutt på Prosedyre